Parálisis cerebral infantil

Semana 17

Crecimiento y Desarrollo

Presente.

Saberes previos:

¿Qué características presenta el niño?

Extraído por: https: // www.rehagirona.com/nos-sumamos-al-dia-mundial-de-la-paralisis-cerebral-infantil/

Lee y analiza el siguiente caso clínico

Paciente de sexo femenino de 11 años de edad con diagnóstico médico de parálisis cerebral Infantil, presenta hipertonía en brazos y piernas, no habla, no camina, se sienta pero no se para, vive con su mamá, actualmente no recibe ningún tratamiento.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=3zCMKIdgiq0

Después de leer el caso clínico , responde a las siguientes preguntas a través de una herramienta digital o el chat/audio

¿Qué tipo de parálisis cerebral presenta el paciente? ¿Qué tipo de tratamiento debe recibir?

Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante identifica los tipos, clasificación y características de la parálisis cerebral infantil, para una correcta valoración e intervención fisioterapéutica oportuna.

Temario:

1. Concepto
2. Tipos
3. Clasificación
4. Características físicas y cognitivas
5. Diagnóstico
6. Test de valoración
7. Tratamiento fisioterapéutico

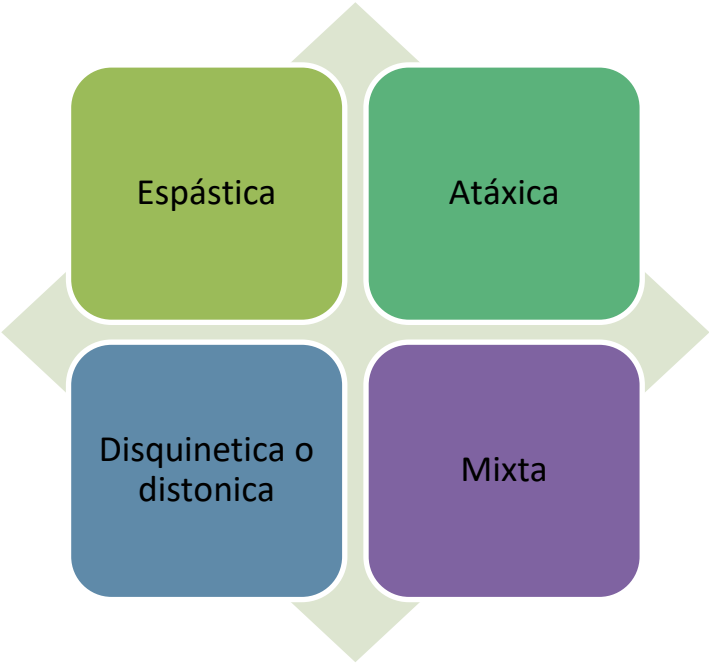
1. Concepto

La parálisis cerebral infantil es un termino usado para describir un grupo de incapacidades motoras producidas por un daño en el cerebro del niño, que pueden ocurrir en el periodo prenatal, perinatal o postnatal .

1. Concepto

La lesión cerebral no es progresiva y causa un deterioro variable de la coordinación en la acción muscular, resultando una incapacidad en el niño para mantener posturas y realizar movimientos normales .

2. Tipos



Parálisis cerebral espástica

Es el tipo de parálisis cerebral más común. Afecta a aproximadamente el 80 % de las personas con parálisis cerebral. Las personas que tienen este tipo de parálisis, tienen mayor tono muscular. Esto significa que sus músculos están rígidos y que, en consecuencia, se mueven con dificultad.

Parálisis cerebral atáxica

Es menos común, afecta únicamente entre el 5 y 10 % de aquellos con esta condición. Este tipo de parálisis cerebral esta causado por daño al cerebelo, localizado cerca de la base del cerebro. Se caracteriza por presentar dificultad con el balance y la coordinación del movimiento. Abarca generalmente todo el cuerpo, afectando las cuatro extremidades y el tronco.

Parálisis cerebral atáxica

Los pacientes con este tipo de parálisis presentan los siguientes síntomas:

- Hipotonía
- Temblores
- Realizan la marcha con una amplia base

Parálisis cerebral disquinetica o distonica

Se caracteriza, principalmente, por movimientos lentos, involuntarios (que se agravan con la fatiga y las emociones, se atenúan en reposo, desapareciendo con el sueño) y descoordinados, que dificultan la actividad voluntaria.

.

Parálisis cerebral disquinetica o distonica

Es común que las personas que tengan este tipo de parálisis cerebral tengan unos músculos que cambian rápidamente de flácidos a rígidos. Sus brazos y sus piernas se mueven de una manera descontrolada, y puede ser difícil entenderles debido a que tienen dificultad para controlar su lengua, su respiración y las cuerdas vocales.

.

Parálisis cerebral mixta

La parálisis cerebral mixta es una combinación de movimientos espásticos y atetosicos. Se hallan combinaciones de diversos trastornos motores, con distintos tipos de alteración del tono muscular.

La forma mixta son muy frecuentes.

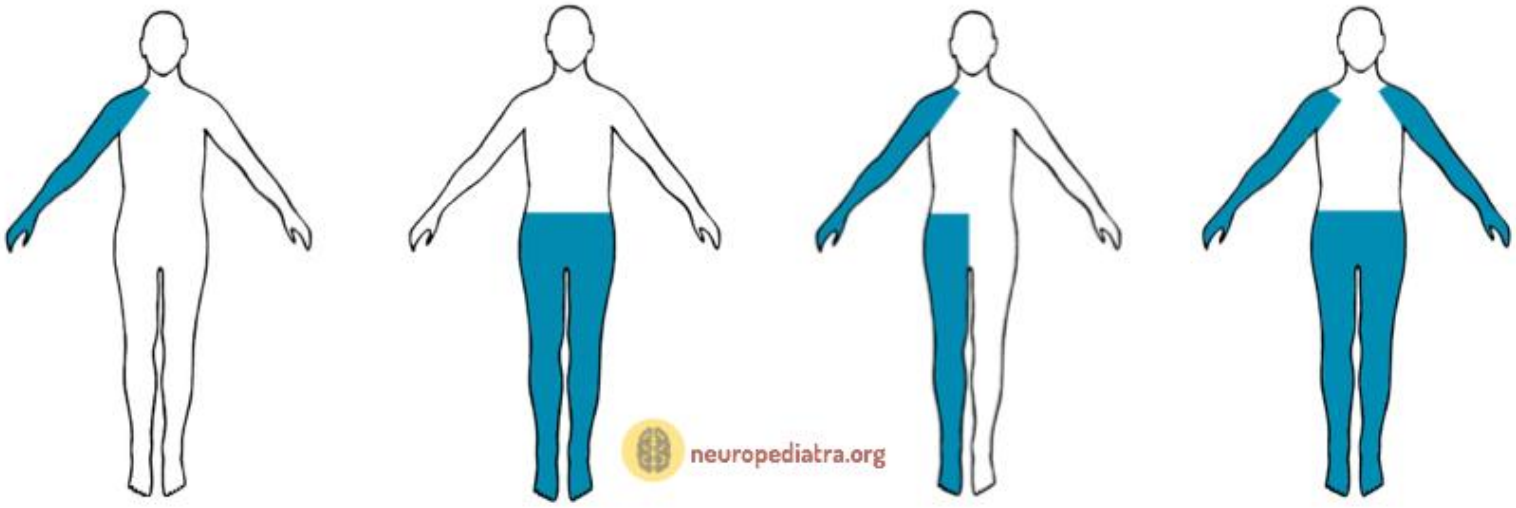
3. Clasificación

- Hemiplejia
- cuadriparesia
- paraplejia
- monoparesia
- triplejia

3. Clasificación

Clasificación	Características
Hemiplejia	Parálisis de un hemicuerpo
Cuadriparesia	Disminución de la fuerza muscular en los 4 miembros
Paraplejia	Parálisis de la mitad inferior del cuerpo
Monoparesia	Parálisis de una extremidad, ya sea superior o inferior.
Triplejia	Cuando están afectadas las 3 extremidades.

3. Clasificación



Monoparesia
afecta sólo un miembro, generalmente el brazo

Diplejia
afecta a ambas piernas

Hemiplejia
un lado del cuerpo afectado

Tetraparesia
afecta los cuatro miembros

4. Características físicas y cognitivas

Características físicas

- atrofias
- retracciones musculares y tendinosas
- deformidades
- problemas de organización del esquema corporal
- alteraciones posturales
- alteraciones del tono muscular
- alteraciones en la marcha
- problemas de equilibrio y coordinación

4. Características físicas y cognitivas

Características cognitivas

- problemas de atención
- problemas en el lenguaje, fonación
- déficits en memoria y aprendizaje
- problemas de organización del esquema corporal

- alteraciones posturales
- alteraciones del tono muscular
- alteraciones en la marcha
- problemas de equilibrio y coordinación

5. Diagnóstico

- Examen físico: no se puede realizar hasta que el bebe tenga de 6 a 12 meses.
- Se obtiene datos sobre los antecedentes prenatales y de nacimiento.
- Se deben verificar los síntomas descritos, poner a prueba los reflejos del niño y observar la tendencia inicial en cuanto a la preferencia de mano.

5. Diagnóstico

Exámenes diagnósticos

- Desarrollo postural
- Reflejos
- Valoración del tono
- Exámenes auxiliares: resonancia magnética, tomografía axial computarizada, electromiografía, etc.

6. Test de valoración

Forma espástica (3 primeros meses)	- Manos cerradas con inclusión del pulgar - Tendencia a la hiperextensión de extremidades inferiores en decúbito o con la suspensión. - Asimetría en movimientos espontáneos o ante estímulos.
Desde los 3 a 6 meses	- Asimetría en los movimientos - Hipertonía de miembros con hipotonía del tronco. - Sedestación con apoyo ausente, inestable con hiperextensión de extremidades.
Forma extrapiramidal	- Rara vez se manifiesta durante la infancia
Forma atónica	- Hipotonía generalizada desde el comienzo con hiperreflexia.
Forma atáxica	- Puede a partir de los 5 - 6 meses con sedestación inestable, incoordinación.

7. Tratamiento fisioterapéutico

- Se centran en la mejora de las habilidades motoras, mejora del equilibrio, la coordinación, la fuerza, resistencia, la integración y mejora sensorial y cognitiva .

7. Tratamiento fisioterapéutico

- Se utilizan diversas técnicas y métodos terapéuticos como el método Bobath.

- Se utiliza el método Bobath para inhibir el tono y los patrones de movimientos anormales, facilitando el movimiento normal y estimulando en caso de hipotonía o inactividad muscular.

7. Tratamiento fisioterapéutico

La intervención fisioterapéutica se realizara en función dela edad, las características, las necesidades, la familia, el entorno, el equipo y la comunidad, siempre teniendo en cuenta que el niño es el principal protagonista de su tratamiento.

El objetivo principal es: “conseguir la máxima funcionalidad para que con sus limitaciones, puedan llegar a su nivel máximo de autonomía y de independencia personal”. La familia será un elemento imprescindible para poder conseguir los objetivos propuestos.

3. Entender

Actividad sincrónica

Elabore un organizador visual sobre los tipos de parálisis cerebral infantil.

Extraído de: https://images.app.goo.gl/SKJc5JRe4wJXBW8X7

Conclusiones

Aportes

- La parálisis cerebral infantil es uno de los trastornos neurológicos que con mayor frecuencia generan discapacidad en la infancia.

Aportes

Aportes

Metacognición

¿Qué aprendimos hoy?
¿Qué dificultades tuvimos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?

Consultas

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.